

CHAPTER 04

易混淆配對題卡

Confusion-Pair Flashcards

2026 年版・第一版

AI-ASSISTED

易混淆病理配對題卡

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生・對比內容為 AI 整理・請對照標準教科書使用

每一張「題卡」一個易混淆主題，含對比表 + 1-2 題練習題 + 答案。建議列印成 A5 雙面，作為實習醫師口袋複習素材。

題卡 #1 — Pemphigus vulgaris vs Bullous pemphigoid

項目	Pemphigus vulgaris	Bullous pemphigoid
抗原	Desmoglein 1/3 (細胞間)	BP180/230 (基底膜)
水皰位置	表皮內 (suprabasal)	表皮下 (subepidermal)
水皰特性	鬆弛、易破	緊張、不易破
Nikolsky sign	陽性	陰性
DIF	網狀魚網樣 IgG	線狀 IgG + C3 沿 BMZ
黏膜侵犯	常見 (口腔)	罕見
年齡	中年	年長
過敏型	Type II	Type II
治療	類固醇 + Rituximab	類固醇 + Doxycycline

練習題: 60 歲男性，口腔多發鬆弛水皰，Nikolsky 陽性。DIF 顯示表皮細胞間網狀 IgG。診斷？
答: Pemphigus vulgaris

題卡 #2 — Crohn disease vs Ulcerative colitis

項目	Crohn	UC
部位	任何處，末端迴腸最常	結腸 + 直腸 (連續)
連續性	skip lesion	連續
深度	transmural	僅黏膜 + submucosa

項目	Crohn	UC
肉芽腫	30% 有	無
瘻管/狹窄	常見	罕見
假性息肉	罕見	常見
鵝卵石外觀	有	無
串珠樣狹窄(影像)	有	無
Toxic megacolon	罕見	可能
結腸 Ca 風險	↑	↑ ↑ ↑
血清抗體	ASCA+	p-ANCA+
抽菸	危險	保護 (?)

練習題: 30 歲女性，水樣血便數月，全結腸鏡見直腸到脾曲連續發炎、假息肉，無正常黏膜跳躍區。最可能診斷？
答: Ulcerative colitis

題卡 #3 — Hodgkin vs Non-Hodgkin lymphoma

項目	Hodgkin lymphoma	Non-Hodgkin lymphoma
腫瘤細胞比例	少數(<5%) = Reed-Sternberg	多數
RS 細胞	雙葉/多葉、貓頭鷹眼	無
RS IHC	CD15+、CD30+、PAX5 弱+、CD45-	視亞型
淋巴結擴散	連續性(順著淋巴管走)	跳躍性
年齡	雙峰: 20s + 60s	多老年
病灶	縱膈、頸	任何
治療	ABVD ± 放療	R-CHOP(B-cell)等
預後	較好	視亞型

練習題: 22 歲男性發現縱膈腫塊，切片：少數雙葉核大型細胞 + 大量反應性 lymphocyte/eosinophil。IHC：CD15+、CD30+、CD45-。診斷？
答: Hodgkin lymphoma

題卡 #4 — Renal oncocytoma vs Chromophobe RCC

項目	Oncocytoma	Chromophobe RCC
良/惡性	良性	惡性
肉眼	mahogany brown、central scar	brown-tan
細胞質	嗜酸顆粒(粒線體)	嗜酸 + microvesicle
細胞膜	不明顯	明顯(plant-cell-like)
Hale's colloidal iron	—	+
電顯	滿是粒線體	微囊泡 + 粒線體
IHC(CK7)	局部 + 或 —	瀰漫強 +
遺傳	Birt-Hogg-Dubé(部分)	Birt-Hogg-Dubé

練習題: 50 歲男性腎切除，肉眼見 4 cm 棕色腫瘤含中央瘢痕。鏡下嗜酸性細胞巢狀排列。電顯：胞質滿粒線體。CK7 弱表現，Hale's colloidal iron 陰性。診斷？**答:** Oncocytoma

題卡 #5 — Coagulative vs Liquefactive vs Caseous vs Fat necrosis

類型	機轉	形態	典型部位
Coagulative	ischemia(除腦外)	嗜酸性 ghost、核淡化	心、腎、脾、肝梗塞
Liquefactive	酶分解	全部融解、可成囊	腦梗塞、化膿
Caseous	結核免疫反應	乾酪樣、無結構	結核、深部真菌
Fat	脂肪酶	鈣皂、玻璃樣脂肪細胞	胰臟炎、乳房外傷
Fibrinoid	免疫複合物	PAS+ 強嗜酸帶	血管炎、惡性高血壓
Gangrenous	combination	黑色、惡臭	下肢、腸缺血

練習題: 32 歲女性突發劇烈上腹痛、血淀粉酶 ↑↑。CT：胰腺周圍多發鈣化點。組織學見鈣皂與玻璃樣脂肪細胞。何種壞死？**答:** Fat necrosis

題卡 #6 — MSA vs Parkinson disease vs DLB

項目	Parkinson	DLB	
α-syn 位置	神經元 Lewy body	神經元 Lewy body	Oligodendrocyte GCI
動作症狀	Parkinsonism	Parkinsonism + 失智	Parkinsonism + ataxia + autonomic
自主神經失調	後期	中後期	早期顯著(直立低血壓、尿便失禁)
早期失智	否	是	否
對 L-DOPA 反應	好	中等	差

練習題: 65 歲男性 parkinsonism + 早期嚴重直立低血壓 + cerebellar ataxia, L-DOPA 反應差。屍檢預期 α-syn 包涵體位於? **答:** Oligodendrocyte (MSA)

題卡 #7 — Cushing syndrome 分類

類型	比例	主要原因	ACTH	DST	治療
Cushing disease (垂體腺瘤)	~70%	垂體 ACTH 瘤	↑	high-dose 抑制	經蝶手術
Ectopic ACTH	~10- 15%	SCLC、carcinoid、bronchial NET、medullary thyroid Ca	↑↑	不抑制	切除腫瘤
Adrenal adenoma	~10%	腎上腺腺瘤(最常見的 ACTH- independent)	↓	不抑制	腎上腺切除
Adrenal carcinoma	~5%		↓	不抑制	切除 + mitotane
Iatrogenic	最多	外源性類固醇	↓	不抑制	減藥

練習題: 45 歲女性 moon face、buffalo hump、bruise。Cortisol ↑、ACTH ↓、Dexamethasone test 不被抑制。CT: 右腎上腺 3cm 腫塊。診斷? **答:** Adrenocortical adenoma (ACTH-independent Cushing)

題卡 #8 — 腦疝(Herniation)四種

疝出類型	推力	壓到結構	臨床表徵
Subfalcine (cingulate)	額葉腫塊	扣帶迴在大腦鎌下、ACA	對側下肢無力

疝出類型	推力	壓到結構	臨床表徵
Transtentorial (uncal)	顳葉腫塊	顳葉鉤回 → CN III、PCA、brainstem	同側 mydriasis、對側偏癱、 Duret 出血 、PCA 區梗塞
Central	廣泛上推	brainstem 下移	意識下降、呼吸異常
Tonsillar	後顳腫塊 / IICP	小腦扁桃體 → foramen magnum、延髓	呼吸停止 (cushing reflex)

練習題：右顳葉外傷血腫，瞳孔右側散大、左側偏癱，後續 brain MRI 見中腦/橋腦中央線性出血。何種疝出？出血如何稱呼？**答：**Uncal (transtentorial) herniation；Duret hemorrhage

題卡 #9 — 三種 Vasculitis (GCA vs PAN vs Kawasaki)

項目	Giant cell arteritis	Polyarteritis nodosa	Kawasaki
血管	大-中	中	中
位置	顳動脈 、頭部	腎、消化道、皮膚	冠狀動脈
年齡	> 50 歲	任何	< 5 歲
病理	granulomatous + giant cell + IEL 斷裂	fibrinoid necrosis、aneurysm	acute necrotizing arteritis
併發	失明	腎衰、腸梗塞	冠狀動脈瘤 、心肌梗塞
血清	ESR/CRP ↑↑	HBV 相關(30%)、p-ANCA 偶 +	多 IVIG、aspirin
治療	高劑量類固醇 (疑即治)	類固醇 + cyclophosphamide	IVIG + aspirin

練習題：70 歲女性新發頭痛 + 視力模糊 + 顳動脈壓痛 + ESR 95。最該立即？**答：**高劑量類固醇(疑 GCA 立刻給，免失明)

題卡 #10 — Anemias 鑑別

類型	MCV	Ferritin	TIBC	骨髓	特徵
IDA	↓	↓	↑	Erythroid hyperplasia	Pencil cell
Anemia of chronic disease	正常/↓	↑	↓	normo	鐵 ↓ 但儲存 ↑

類型	MCV	Ferritin	TIBC	骨髓	特徵
Thalassemia	↓	正常/↑	正常	erythroid hyperplasia ↑↑	Target cell、HbF/HbA2 ↑
Megaloblastic	↑↑	正常	正常	hyperplasia、 megaloblast、giant band	Hypersegmented PMN、 B12/folate ↓
Aplastic	正常	正常	正常	空蕩、被脂肪取代	Pancytopenia
Sideroblastic	視亞型	↑	↓	Ring sideroblast	鉛中毒、酒精
Hemolytic	正常/ ↑	視	視	erythroid hyperplasia	Retic ↑、LDH ↑、 haptoglobin ↓

練習題: 60 歲男性 Hb 6.5、MCV 75、TIBC ↑、Ferritin 8、blood smear 見 pencil cell。診斷？下一步檢查？

答: IDA；要找出血源（大腸鏡 + 胃鏡）

題卡 #11 — 病毒-腫瘤關聯(必背)

病毒	相關腫瘤/疾病	機轉/檢測
HPV 16/18	Cervical/Anal/HNSCC/Vulvar/Penile SCC、Condyloma	E6→p53、E7→Rb； p16 IHC
EBV	Burkitt-endemic、Hodgkin、NK/T、NPC、Gastric Ca-EBV+、PTLD、 Hairy leukoplakia	EBER ISH
HHV-8 (KSHV)	Kaposi sarcoma 、 Primary effusion lymphoma 、Multicentric Castleman	LANA IHC
HTLV-1	ATLL(成人 T 細胞白血病/淋巴瘤)	血清、PCR
HBV / HCV	HCC；HCV 也與 B-cell NHL	血清、PCR
JC virus	PML (PMLE)	CSF PCR
MCPyV	Merkel cell carcinoma	IHC
HIV	Kaposi、CNS lymphoma、Burkitt、HHV-8/EBV 機會感染	—

練習題: HIV 患者多發紫紅斑塊、PEL、Multicentric Castleman 三種疾病的共同病原？**答:** HHV-8(KSHV)

題卡 #12 — 蝕骨細胞(Osteoclast)相關 vs 不相關骨病

疾病	細胞問題	機轉
Osteopetrosis	osteoclast 功能不足	CA II、CLCN7 突變 → 骨吸收 ↓
Post-menopausal osteoporosis	osteoclast 過度活化	雌激素 ↓ → RANKL ↑ → osteoclast ↑
Senile osteoporosis	osteoblast 老化	與 osteoclast 無關
Osteomalacia/Rickets	礦化不足	Vit D 缺乏 → 與 osteoclast 無關
Paget disease	osteoclast 異常巨大	"mosaic" 骨; alkaline phosphatase ↑ ↑

練習題: 65 歲女性 OP 患者, DEXA T-score -3.0, 最主要的細胞病生? **答:** osteoclast 過度活化 (post-menopausal OP)

題卡 #13 — Necrosis types: 必背配對

類型	經典疾病 / 部位
Coagulative	MI、腎梗塞、脾梗塞
Liquefactive	腦梗塞、化膿性感染
Caseous	結核、深部真菌
Fat (enzymatic)	急性胰臟炎、乳房外傷
Fibrinoid	惡性高血壓、血管炎、PAN
Gangrenous	糖尿病足、腸缺血、肢端凍傷

練習題: 胰島炎症的乳化脂肪 + 鈣皂沉積。屬於哪種壞死? **答:** Fat necrosis

題卡 #14 — 自體免疫肝臟病 (AIH vs PBC vs PSC)

項目	Autoimmune Hepatitis	Primary Biliary Cholangitis	Primary Sclerosing Cholangitis
抗體	ANA + SMA (type 1); LKM-1 (type 2)	AMA (>95%)	p-ANCA (70%); MRCP 串珠樣
Ig	IgG ↑	IgM ↑	IgG4 + 偶
性別	女 >> 男	女 >> 男 (中年)	男 > 女 (合併 UC)

項目	Autoimmune Hepatitis	Primary Biliary Cholangitis	Primary Sclerosing Cholangitis
病理	interface hepatitis、plasma cell	floral duct lesion、肉芽腫	onion-skin 纖維化
治療	類固醇 + AZA	UDCA 、Obeticholic acid	無有效藥；肝移植
風險	肝硬化、HCC	肝硬化、osteoporosis	膽管癌 (CCA)

練習題：45 歲 UC 男性，rising ALP、MRCP 見肝外膽管「串珠樣」狹窄。診斷？將來需警惕？ **答：**PSC；膽管癌風險

題卡 #15 — 三種 IBD 之外的腸道感染症

病原	形態	臨床
C. difficile	Pseudomembrane 、火山樣破裂	抗生素後腹瀉
Whipple (Tropheryma)	PAS+ 巨噬細胞充滿小腸黏膜	體重↓、關節痛、神經症狀
Yersinia	末端 ileum + appendix、 偽結核樣	似 Crohn、appendicitis
阿米巴 (E. histolytica)	flask-shaped ulcer	血便、肝膿瘍
賈第 (Giardia)	表面附著、絨毛萎縮	慢性腹瀉、營養不良
MAC (HIV+)	foamy 巨噬細胞充滿黏膜 + AFB+	末期 AIDS

練習題：50 歲男性慢性腹瀉、關節痛、體重↓、神經症狀。小腸切片見 PAS+ 巨噬細胞滿絨毛。診斷？ **答：**Whipple disease

題卡 #16 — 乳癌四大亞型治療快速分流

分型	ER/PR/HER2	比例	治療主力
Luminal A	ER+/PR+/HER2- (Ki67 ↓)	~50%	Tamoxifen / AI (內分泌)
Luminal B	ER+/PR+/HER2± (Ki67 ↑)	~15%	內分泌 + 化療 ± Trastuzumab
HER2-enriched	ER-/PR-/HER2+	~10-15%	Trastuzumab + Pertuzumab 、T-DXd
Triple negative	ER-/PR-/HER2-	~15-20%	化療 (pembrolizumab if PD-L1+)

練習題: 55 歲女性 IDC, ER 95%、PR 80%、HER2 1+ (FISH 未擴增)、Ki67 8%。分型? 首選治療? **答:** Luminal A; Aromatase inhibitor

題卡 #17 — 三種 RCC subtype

類型	比例	細胞外觀	分子
Clear cell RCC	70-80%	clear cytoplasm (lipid + glycogen)	VHL 失活、3p25 缺失
Papillary RCC	10-15%	papillary、foamy macrophage	MET mutation; type 1/2
Chromophobe RCC	5%	嗜酸、plant-cell-like	TP53、PTEN; BHD syndrome
Collecting duct	罕見	高侵犯性	INI-1 失 (部分)

練習題: 腎切除標本見金黃色軟腫塊伴出血壞死, 鏡下 clear cell 巢狀。分子最相關? **答:** VHL (3p25 缺失)

題卡 #18 — 子宮頸病變等級

等級	HPV 機制	細胞分布	病理
LSIL (CIN I)	productive infection	下 1/3 上皮 atypia	Koilocyte
HSIL (CIN II-III)	integration	2/3 以上上皮 atypia	mitotic 上層、p16 瀰漫強+
Invasive SCC	完全侵犯	突破基底膜	desmoplasia

練習題: 63 歲女性子宮頸切片, 全層上皮 atypia + 多 mitotic figure 達上層, p16 瀰漫強+。診斷? **答:** HSIL (CIN III)

題卡 #19 — Hepatocellular Adenoma 4 大分子分型 (新版)

分型	IHC 標記	HCC 惡變風險	臨床
HNF1α-inactivated	LFABP 失	極低	MODY-3、女性
Inflammatory	SAA+、CRP+、glutamine synthetase 區域+	中等	肥胖、酗酒
β-catenin-activated	nuclear β -catenin+、GS 瀰漫+	高 (最需警惕)	男性、雄性激素
Unclassified	無特異	不定	—

練習題:30 歲女性口服避孕藥史,肝切除標本 IHC:LFABP 完全失表現,β-catenin 不入核。分型?惡變風險?
答:HNFlα-inactivated;極低

題卡 #20 — α1-AT vs CF vs 矽肺 vs IPF (慢性肺病分子病因)

疾病	分子缺陷	病理
α1-antitrypsin def.	SERPINA1 突變(PiZZ)→ 肝 ER 滯留(PAS+ 球)	Panacinar 肺氣腫 (下肺)
Cystic fibrosis	CFTR 突變 → ↓ Cl ⁻ 分泌	黏稠分泌 → 支擴、慢性感染
Silicosis	silica → macrophage 釋出 IL-1、TGFβ	上肺 nodule、whorled collagen
IPF	UIP pattern: 患者間質纖維化	蜂窩肺、fibroblast foci

練習題:45 歲男性非吸菸者下肺氣腫 + 肝硬化。最該檢測? **答:**α1-antitrypsin (PiZZ)

題卡 #21 — Plexiform lesion 在哪一階段?

肺高壓病理階段 (Heath-Edwards 分類):

- I. Medial hypertrophy
- II. Intimal cellular proliferation
- III. Intimal **concentric** fibrosis("onion-skin" 在腎、PAH 都見得到)
- IV. **Plexiform lesion** ← 晚期
- V. Necrotizing arteritis
- VI. Fibrinoid necrosis

練習題:肺活檢見 plexiform lesion,代表 PAH 處於哪期?早期還是晚期? **答:**晚期(grade IV)

題卡 #22 — 鼻咽癌 vs 口咽 vs 喉

部位	主因	病理形態	標誌
鼻咽(NPC)	EBV	non-keratinizing(淋巴上皮癌)	EBER+
口咽(OPSCC)	HPV-16	basaloid SCC	p16+
喉	抽菸 + 酗酒	經典 keratinizing SCC	p16-
口腔	抽菸 + 檳榔	keratinizing SCC	TP53、CDKN2A、PIK3CA 突變

練習題: 50 歲台南男性頸部腫塊先表現，鼻咽切片：non-keratinizing carcinoma with lymphocytic stroma，EBER+。診斷？**答:** Nasopharyngeal carcinoma (EBV-related)

題卡 #23 — Acute cellular vs Acute antibody-mediated rejection

項目	Acute cellular	Acute AMR
主要機制	T 細胞	DSA (抗體)
病理	淋巴細胞 tubulitis、endothelialitis	微血管炎、glomerulitis、peritubular cap. C4d
C4d	陰性	陽性
DSA	陰性	陽性
治療	高劑量類固醇、ATG	血漿置換、IVIG、Rituximab

練習題: 移植腎切片淋巴細胞浸潤管壁 + tubulitis，C4d 陰性。診斷？治療？**答:** Acute cellular rejection；高劑量類固醇

題卡 #24 — EATL vs MALT 淋巴瘤

項目	EATL	MALT (Extranodal MZL)
細胞來源	T 細胞	B 細胞
相關疾病	Celiac disease	H. pylori 胃、Hashimoto 甲狀腺、Sjögren 腮腺
IHC	CD3+、CD30+、CD56±	CD20+、CD5-、CD23-
治療	化療(差預後)	去除誘因(抗 H. pylori 即可消退)、Rituximab

練習題: celiac 患者腹痛、體重下降，腸切片見 CD3+ CD30+ 淋巴瘤性細胞。診斷？**答:** Enteropathy-associated T-cell lymphoma (EATL)

題卡 #25 — 蛋白沉積病 (Amyloidosis)

類型	蛋白	來源
AL	Ig light chain	Multiple myeloma、MGUS
AA	SAA	慢性發炎(RA、IBD、結核)

類型	蛋白	來源
ATTR	Transthyretin	senile(wild-type)、familial(mutation)
A β	β -amyloid	Alzheimer
AIAPP	Islet amyloid polypeptide	Type 2 DM
A β 2M	β 2-microglobulin	長期血液透析

染色:Congo red → 偏光下 apple-green birefringence

練習題:MM 患者腎切片見 Congo red+ 紫紅沉積、偏光下 apple-green。屬於哪型? 答:AL amyloidosis

題卡 #26 — 三大病毒性肝炎慢性化風險

病毒	慢性化率	HCC 風險	特徵
HAV	0%	—	急性、糞口、不慢性
HBV	成人 5%、新生兒 90%	↑ ↑	不需肝硬化即可 HCC
HCV	60-80%	↑ ↑	多進展至肝硬化才 HCC
HDV	與 HBV 共感染	↑	重症惡化
HEV	0%	—	孕婦致命

練習題:未接種疫苗成人感染 HBV,慢性化機率?新生兒呢? 答:5%;90%

題卡 #27 — 高度卵巢漿液性癌 vs 子宮內膜樣 vs 透明細胞 vs 黏液性

類型	起源	分子	IHC
HGSC	輸卵管 fimbriae(STIC)	TP53 >96%、BRCA	WT1+、p53 異常、p16+
LGSC	卵巢表面	KRAS、BRAF、NRAS	WT1+、p53 wild
Endometrioid	子宮內膜異位	PTEN、PIK3CA、ARID1A	ER+、PR+
Clear cell	子宮內膜異位	ARID1A、PIK3CA	HNF1 β +、Napsin A+
Mucinous	多原發於 GI 轉移	KRAS	CK7、CK20±(要區分 GI 轉移)

練習題: 60 歲女性 stage III 卵巢漿液性癌, TP53 突變。最可能對哪種治療反應佳 (若伴 BRCA mut)? **答:** PARP inhibitor (olaparib)

題卡 #28 — 三大慢性甲狀腺炎

疾病	抗體	病理	臨床
Hashimoto	TPO + Tg	Hürthle cell、lymphoid follicle	慢性 hypothyroidism (早期可短暫 hyper)
Graves	TSI / TRAb (激活)	hyperplasia、scalloped colloid	Hyperthyroidism + ophthalmopathy + pretibial myxedema
Subacute (de Quervain)	病毒後	多核巨細胞、肉芽腫	痛 + 暫時 hyper → euthyroid
Riedel	IgG4 相關	緻密纖維化 侵犯周圍	硬如木、可能壓迫

練習題: 35 歲女性甲狀腺彌漫腫大 + exophthalmos + 心悸。抗體? 病理? **答:** TSI / TRAb; hyperplasia + scalloped colloid + ophthalmopathy

題卡 #29 — 三大遺傳模式陷阱

模式	例子	特徵
AD	Marfan、HD、FAP、NF、ADPKD、HCM	每代發病、雙性別、不跳代
AR	CF、Wilson、Phenylketonuria、Sickle cell、Tay-Sachs	通常跳代、父母為帶因
XR	Hemophilia A/B、DMD、G6PD def 、Color blindness、Lesch-Nyhan	男性多、母系遺傳
XD	Rett、Vit D-resistant rickets	母→子女都可、男性常較重
Mt 母系	Leber optic、MERRF、MELAS	只母系傳、男女皆病
Imprinting	Prader-Willi (父缺)、Angelman (母缺)	同基因不同來源
Repeat expansion	Huntington (CAG)、Fragile X (CGG)、Myotonic dystrophy (CTG)	Anticipation

練習題: 男童僅有舅舅同症, 母親無症狀。最可能哪種遺傳? **答:** X-linked recessive

題卡 #30 — 神經內分泌腫瘤 (NET) markers

標記	染色
Chromogranin A	dense core granule
Synaptophysin	small vesicle
CD56	NCAM
INSM1	新興廣譜 NE marker (敏感度高)
Specific:	Insulinoma=Insulin、Gastrinoma=Gastrin、Glucagonoma=Glucagon

練習題：胰尾腫瘤 IHC: synaptophysin+、chromogranin A+、Ki67 < 2%。診斷？**答：**Well-differentiated pancreatic NET (G1)

使用建議

- **每週 5-6 張題卡：**搭配 12 週教學排程
- **晨會 10 分鐘快測：**隨機抽 1 張，學生口述對比
- **錯題回饋：**模擬考錯題回去查對應題卡
- **延伸學習：**每張題卡可擴充成完整 case discussion (提供臨床情境)